

100首方剂解读

方剂卡片合集 PDF 预览版

当前导出

12 首

资料形式

方剂卡片 / 目录索引 / 学习提示

定位

中医方剂学习资料

本次包含

大陷胸汤、橘枳姜汤、薏苡附子败酱散、桂枝汤、小青龙汤、葛根芩连汤、桂枝甘草汤、甘草附子汤、厚朴生姜半夏甘草人参汤、茯苓饮、麦门冬汤、葶苈大枣泻肺汤

学习资料，仅供中医学习交流，不作为诊疗处方依据。具体用药请咨询专业医师。

导出时间：2026-06-05 17:13

小小梦学中医

目录索引

按当前数据库更新时间排序

01 大陷胸汤

里证 / 半证 / 水证

主抓手：心下至少腹硬满而痛不可近，或心下痛按之石硬。；必须同时找里热/里实证据：舌燥而渴、便秘、...

02 橘枳姜汤

气证

胸中气塞为主，胸满、心下憋、堵闷明显；短气可见，但短气不是主症；短气急迫为主者偏茯苓杏仁甘草汤，

03 薏苡附子败酱散

里证 / 水证 / 血证 / 阴证

肠痈脓已成、腹皮急而按之濡、身无热而脉数是核心入口。；腹部看似肿胀，但按之软、腹无积聚，不同于少...

04 桂枝汤

表证 / 里证 / 血证

汗出恶风是第一抓手，不是见发热就用。；头痛、发热、鼻鸣、干呕，可构成太阳中风证。

05 小青龙汤

表证 / 里证 / 水证 / 气证

伤寒表不解，心下有水气是方证核心。；咳喘、痰涎清稀量多、鼻流清涕，舌苔白滑。

06 葛根芩连汤

表证 / 半证 / 里证

太阳桂枝证误下，利遂不止是条文入口。；下利偏热：臭秽、黏滞、肛门灼热、口苦口干、苔黄腻。

07 桂枝甘草汤

表证 / 水证 / 气证

发汗过多后心下悸，欲得按。；叉手自冒心是强佐证，活动后更易诱发。

08 甘草附子汤

阴证 / 表证 / 里证 / 水证 / 气证

骨节疼烦，掣痛不得屈伸，近之则痛剧是核心。；汗出短气、小便不利、恶风不欲去衣，提示虚寒湿痹。

09 厚朴生姜半夏甘草人参汤

证 / 气证

腹胀满，虚胀为特征；腹胀按之不坚，不甚痛，时轻时重

10 茯苓饮

里证 / 水证 / 气证

胸满、腹胀、心下痞，兼食欲不振；胃中停饮：吐水、痰水、胃内振水音或苔厚腻

11 麦门冬汤

里证 / 水证 / 气证

咳逆、咽干口燥、咽喉不利者；咳逆上气，咳嗽较深

12 葶苈大枣泻肺汤

半证 / 水证

痰黏壅盛，喘不得卧；支饮不得息，呼吸困难



大黄



芒硝



甘遂

大陷胸汤

01/12

里证

半证

水证

组成

大黄6 芒硝16 甘遂1

病理

里实

里热

半热

水实

病理症状

里实

心下痛、按之石硬，拒按明显。

里热

舌上燥而渴、日晡所小有潮热、烦躁、心胸大烦。

半热

胸胁水热互结，外无大热或但头汗出，兼见心中懊憹、短气躁烦。

水实

胸膈痞满、短气、不能平卧、但头微汗出

临床症状

心下痛、按之石硬、从心下至少腹硬满而痛、不可近、心胸大烦、短气躁烦、心中懊憹、胸膈痞满

慎用人群

大陷胸汤为峻下逐水攻结方，甘遂有毒，硝黄量大，非水热互结、里实拒按者不可轻用。

辨证要点

主抓手：心下至少腹硬满而痛不可近，或心下痛按之石硬。

必须同时找里热/里实证据：舌燥而渴、便秘、潮热、烦躁、苔黄燥、脉洪大。

必须同时找水结证据：胸胁痞闷、短气、不能平卧、但头微汗出、胸腹积水。

无少阳证是与大柴胡汤的重要边界；若往来寒热、胸胁苦满明显，应优先考虑。

只是心下满而不痛，多属痞证，宜半夏泻心汤类，不可误下。

正在心下、按之则痛、病位浅小，多属小陷胸汤；大陷胸汤病势更深、更重。

本方为峻剂，甘遂有毒，非实热水结、拒按石硬者不可轻用。

相关原文

《伤寒论》134：太阳病，脉浮而动数，头痛发热，微盗汗出，而反恶寒者，表未解也；医反下之，动数变迟，膈内拒痛，短气躁烦，心中懊憹，阳气内陷，心下因硬，则为结胸，大陷胸汤主之。若不大结胸，但头汗出，余处无汗，剂颈而还，小便不利，身必发黄也，宜大陷胸丸。

《伤寒论》135：伤寒六七日，结胸热实，脉沉而紧，心下痛，按之石硬者，大陷胸汤主之。

医案

医案1：曹颖甫《经方实验录》大陷胸汤证。患者陈姓男孩，14岁，骤病；见脉洪大、大热、口干、自汗，右足伸屈不利，胸部如塞，按之似痛，不胀不硬；大便五日未通，口渴但终日不欲饮水。曹氏辨为上膈湿痰与阳明燥热同病，处大陷胸汤：制甘遂4.5g，大黄9g，芒硝6g。服后大便畅通，燥屎与痰涎先后俱下，诸症霍然。十二字病理分析：半热：胸部如塞、湿



橘皮



枳实



姜

橘枳姜汤

02/12

气证

组成

橘皮16 枳实3 生姜8

病理

气实

病理症状

气实

胸满痞塞、短气堵闷；暖气频作，暖后觉舒

临床症状

胸中气塞、胸满痞塞、短气堵闷、暖气频作、暖后觉舒、气上冲咽喉、咽喉噎塞、习习如痒

慎用人群

胸痹以疼痛、心绞痛样发作为主者，不可只按橘枳姜汤处理；阴虚火旺、实热上炎而咽干灼痛者慎用。

辨证要点

胸中气塞为主，胸满、心下憋、堵闷明显

短气可见，但短气不是主症；短气急迫为主者偏茯苓杏仁甘草汤。

暖气频作，暖后觉舒

满闷而不以疼痛为主；胸痛明显者不可只按本方处理

相关原文

《金匮要略·胸痹心痛短气病》：胸痹，胸中气塞，短气，茯苓杏仁甘草汤主之，橘枳姜汤亦主之。

《肘后》《千金》：治胸痹，幅幅如满，噎塞习习如痒，喉中涩燥，唾沫。

医案

《金匱名醫驗案精選》咳嗽案：何某，男，34岁。咳嗽已五年，久治未愈，西医诊为支气管炎，曾用棕色合剂、青霉素等；中医按久嗽用半夏露、麦金杏仁糖浆等，皆不效。细询其咳虽久而不剧，痰亦不多，主要表现为入夜胸中似有气上冲至咽喉，呼吸作声、短气，胃脘、胸肋及背部隐隐作痛，畏寒、纳减，脉迟而细，苔薄白。证似《金匱》胸痹胸中气塞短气。

...

胡希恕解析

橘枳姜汤以行气为主，以治胸中气塞。胸中气塞也没有不短气的，但要以胸中气塞为主才用橘枳姜汤；如果以短气、呼吸困难为主，胸虽也闷但不是主要的，则用茯苓杏仁甘草汤祛水，这偏向胸中有水饮，气被水饮阻遏。橘皮一斤用量很重，不这样不足以去气、去气塞；枳实佐橘皮以行气、消胀满；生姜既祛水，也治逆气上冲，主要是上面阳虚、寒气往上攻，只用

...



薏苡仁



附子



败酱草

薏苡附子败酱散

03/12

里证

水证

血证

阴证

组成

薏苡仁10 附子2 败酱草5

病理

里虚

里热

水实

血实

阴证

病理症状

里虚

腹皮急而按之濡、腹无积聚

里热

腹内有痈脓、脉数

水实

腹如肿状、湿毒脓水、皮肤流黄水。

血实

肠痈、皮肤甲错、顽固痼疾。

阴证

局部机能不足

临床症状

腹痛或右下腹隐痛、腹皮急、按之濡、腹如肿状、腹无积聚、身无热而脉数、皮肤甲错、皮肤粗糙脱屑

慎用人群

实热炽盛、高热剧痛拒按、急腹症疑似阑尾穿孔等，须及时就医，不可自行套方。

辨证要点

肠痈脓已成、腹皮急而按之濡、身无热而脉数是核心入口。

腹部看似胀肿，但按之软、腹无积聚，不同于少腹硬满拒按的实证。

其身甲错很重要，可外推到皮肤粗糙如鳞、痈癰、湿疹、手掌肿痒流黄水

方中附子用量很轻，作用在鼓动正气、振瘀滞之气以排脓，不可因见附子

相关原文

《金匱要略·疮痈肠病浸淫病》：肠痈之为病，其身甲错，腹皮急，按之濡，如肿状，腹无积聚，身无热，脉数，此为腹内有痈脓，薏苡附子败酱散主之。

医案

医案1（胡希恕经验，薏苡附子败酱散治疗手掌肿痒流黄水）：1972年河南一女孩，手掌肿痒流黄水，类似鹅掌风剧证，久治不愈。胡老思及本方“其身甲错”可活用于皮肤病，当时无败酱草，即以生薏苡仁30克、附子6克为方，1剂知，连服6剂即复常。十二字病理分析：里热：流黄水、肿痒为湿热毒郁、化脓外泄。里虚：久治不愈，正气不足以自排湿毒。水实：...

胡希恕解析

“其身甲错”为瘀血外候，肠痈至少有瘀血问题；“腹皮急，按之濡”是外面弦急而里面柔软，像有肿状。“腹无积聚，身无热”一方面说明虚证，一方面说明已经化脓、里头没有痞块。脉数本应有热，但痈脓常见脉数而身无热。薏苡、败酱是寒性的排脓药，附子用量很轻，目的不是大温，而是稍加亢奋补益之品以助排脓。要点总结：胡希恕抓住痈脓已成而正气...



桂枝



芍药



甘草



姜



大枣

桂枝汤

表证

里证

血证

组成

桂枝3 芍药3 炙甘草2 生姜3 大枣12枚

病理

表虚

里虚

血虚

病理症状

表虚

营卫不和，腠理不固，汗出恶风、发热头痛。

里虚

胃气与津液略虚，故用姜枣草扶中化源；可见乏力、干呕、口不渴。

血虚

芍药合甘草、大枣养血缓急，兼顾腹直肌拘急、身痛、津血不足。

临床症状

恶风寒、汗出、发热、头痛、项强、鼻鸣、干呕、口不渴

慎用人群

脉浮紧、发热无汗、身痛明显者不可与桂枝汤；酒客、里热炽盛、大渴、大便燥实者须另辨。资料仅供学习，不作诊疗处方依据。

辨证要点

汗出恶风是第一抓手，不是见发热就用。

头痛、发热、鼻鸣、干呕，可构成太阳中风证。

脉多浮缓、浮弱、浮虚；人常偏虚，汗孔关不住。

可治定时发热自汗，关键是“先其时”服药取微汗。

表实无汗、脉浮紧、身痛重者禁用原方，应与麻黄汤、葛根汤类鉴别。

相关原文

《伤寒论》12：太阳中风，阳浮而阴弱；阳浮者热自发，阴弱者汗自出；啬啬恶寒，淅淅恶风，翕翕发热，鼻鸣干呕者，桂枝汤主之。

《伤寒论》13：太阳病，头痛，发热，汗出，恶风，桂枝汤主之。

《伤寒论》15：太阳病，下之后，其气上冲者，可与桂枝汤；若不上冲者，不得与之。

...

医案

医案1（胡希恕经方故事，桂枝汤治定时发热汗出）：一厨师患定时发热汗出二十余年，发作时发热继而汗出，汗后如常人。胡老据“时发热、自汗出”属卫气不和，予桂枝汤，嘱先其时服药取微汗，服后病止。十二字病理分析：表虚：定时汗出、汗后如常，是营卫不和、腠理失约，先其时微汗以和营卫。里虚：病程二十余年，久病而正气不足，需姜枣草扶中化源

...

胡希恕解析

胡希恕强调桂枝汤不是单纯“发汗方”，而是太阳中风表虚、营卫不和的代表方。汗已出而邪仍不解，是正气、津液不足以祛邪；桂枝、生姜解表兼健胃，甘草、大枣安中养液，芍药养血敛营，使微汗出而营卫和。

小青龙汤



麻黄



芍药



细辛



干姜



甘草



桂枝



五味子



半夏

表证

里证

水证

气证

组成

麻黄3 芍药3 细辛3 干姜3 炙甘草3 桂枝3 五味子半升

...

病理

表实

里寒

里虚

水实

气逆

病理症状

表实

外寒束表，恶寒发热、无汗或表不解。

里寒

寒饮内停，干姜、细辛温里散寒。

里虚

胃气不足，水饮不化，易见纳呆、干呕、乏力。

水实

心下有水气，咳喘、痰涎清稀量多、流清涕、舌苔白滑。

气逆

水饮上犯于肺，咳逆喘息、不得卧。

临床症状

咳嗽、喘、痰多清稀、鼻鸣流清涕、恶寒、发热、胸闷、干呕

慎用人群

细辛、麻黄、干姜辛温发散，阴虚燥咳、痰黄口渴、里热烦躁、津伤明显者慎用；细辛剂量与炮制须遵医嘱。资料仅供学习。

辨证要点

伤寒表不解，心下有水气是方证核心。

咳喘、痰涎清稀量多、鼻流清涕，舌苔白滑。

多不渴；若服后口微渴，可为寒饮去、津液复布。

可见干呕、下利、小便不利、少腹满、噎、喘等或然证。

黄痰、口渴烦躁、舌红苔黄等热象明显者慎用原方。

相关原文

《伤寒论》40：伤寒表不解，心下有水气，干呕，发热而咳，或渴，或利，或噎，或小便不利，少腹满，或喘者，小青龙汤主之。

《伤寒论》41：伤寒，心下有水气，咳而微喘，发热不渴；服汤已渴者，此寒去欲解也，小青龙汤主之。

《金匮要略·痰饮咳嗽病》：病溢饮者，当发其汗，大青龙汤主之，小青...

医案

医案1（矢数道明《汉方临床治验精粹》）：小儿哮喘，平素易感冒，感冒时咽红、扁桃体肿大，咳嗽，咯大量湿性稀薄痰，喷嚏、鼻涕多，食欲尚可。予小青龙汤提取物，服药3个月后体力精神转佳，感冒减少，哮喘发作消失。十二字病理分析：表实：易感冒、鼻喷嚏，为表邪易犯、表不解。里寒：痰涕清稀湿性，属寒饮。水实：大量稀薄痰、鼻涕多为水饮上犯。

...

胡希恕解析

胡希恕强调小青龙汤的主线是外邪未解，内有寒饮。单发汗不能解表，因为心下水气未去；麻黄、桂枝解表，干姜、细辛、半夏、五味子温里祛饮止咳。若黄痰、口渴、烦躁热象明显，须考虑加石膏或另辨。



葛根



甘草



黄芩



黄连

葛根芩连汤

表证

半证

里证

组成

葛根半斤 炙甘草2 黄芩3 黄连3

病理

表虚

半热

里热

里虚

病理症状

表虚

太阳桂枝证误下后，表未解，可见汗出、项背不舒、脉促。

半热

胸膈烦热，喘而汗出，热势外越。

里热

热利不止，大便臭秽、肛门灼热、口苦口干。

里虚

误下伤中，甘草缓急和中，防苦寒太过。

临床症状

发热、下利不止、腹痛、大便黏滞臭秽、肛门灼热、汗出、喘、胸闷烦热

慎用人群

清谷不化、腹冷喜温、脉沉迟弱为寒利，不宜用本方；苦寒药偏多，胃虚明显者慎。资料仅供学习。

辨证要点

太阳桂枝证误下，利遂不止是条文入口。

下利偏热：臭秽、黏滞、肛门灼热、口苦口干、苔黄腻。

兼汗出、喘、胸中烦热，或项背拘急、头身困重。

葛根量宜足，尤其项背强痛、头痛、下利并见时。

寒性下利、清谷不化、脉沉迟微弱者不宜。

相关原文

《伤寒论》34：太阳病，桂枝证，医反下之，利遂不止；脉促者，表未解也；喘而汗出者，葛根黄芩黄连汤主之。

医案

医案1（矢数道明《临床应用汉方处方解说》）：男孩，4岁，突然高热至40℃，意识不清，泻下臭秽黏液便，并见促脉。予葛根黄连黄芩汤后，发热逐渐下降，下利减少；第3日热退。后因口渴、水入口即吐、烦躁、小便不利，转五苓散，呕吐止而愈。十二字病理分析：表虚：促脉、突发外感样高热，提示表未解。半热：高热、意识不清、烦躁，为热势上扰。里热：

胡希恕解析

胡希恕认为本方治桂枝汤证误下后，外邪乘虚入里而成协热利：表未解，里有热，下利不止，并见喘而汗出。葛根大量解肌透表并止利，黄芩、黄连清里热止热利，甘草缓急。



桂枝



甘草

桂枝甘草汤

07/12

表证

水证

气证

组成

桂枝4 炙甘草2

病理

表虚

津虚

气实

病理症状

表虚

发汗过多后表阳受损，可见汗出、畏风或体表不固。

津虚

汗为津液，过汗伤津，甘草补中益津。

气实

气上冲于心胸，心下悸、叉手自冒心、欲得按。

临床症状

心悸、心下悸、胸闷、汗出、头晕、坐卧不安、叉手自冒心、面色苍白

慎用人群

心悸需先排除严重心律失常等急症；痰饮眩悸、水肿阴证、虚热脉结代不可只按本方处理。甘草量大时注意水钠潴留风险。

辨证要点

发汗过多后心下悸，欲得按。

叉手自冒心是强佐证，活动后更易诱发。

心悸多为阵发、一过性，心胸部气冲感集中。

桂枝、甘草比例约2:1，剂量过小常不效。

水饮眩冒、阴证水肿、虚热脉结代要分别转向苓桂术甘汤、真武汤、炙甘草汤。

相关原文

《伤寒论》64：发汗过多，其人叉手自冒心，心下悸，欲得按者，桂枝甘草汤主之。

医案

医案1（门纯德医案）：男，46岁，雨中外感后自服大剂葱姜红糖汤，得大汗后风寒虽解，却失眠3个月。诊见面色青，双目布满血丝，彻夜不卧、烦躁徘徊，白天蜷卧少言少食，脉弦细，舌淡苔少。安神药少效。予桂枝甘草汤，睡前服，次晨酣睡。十二字病理分析：表虚：过汗后病起，表阳受损。津虚：大汗伤津，舌淡苔少。气实：烦躁不卧、心神不安，为气冲心...

胡希恕解析

胡希恕说夺汗则亡血，发汗过多，心气不足而悸；汗多多出于上体，上下体液骤然失调，形成心胸气上冲，故用桂枝降冲、甘草补中缓急。



甘草



附子



白术



桂枝

甘草附子汤

阴证

表证

里证

水证

组成

炙甘草2 炮附子2枚 白术2 桂枝4

病理

阴证

表虚

里虚寒

水实

气逆

病理症状

阴证

机能沉衰，恶风不欲去衣，脉多沉细弱。

表虚

风湿在表，汗出恶风，关节疼痛。

里虚寒

虚寒为本，附子温阳，甘草扶中。

水实

湿饮停着关节，身微肿，小便不利。

气逆

短气、胸闷、气上冲，影响水液下行。

临床症状

关节剧痛、掣痛不得屈伸、近之则痛剧、关节肿胀、恶风不欲去衣、汗出、短气、小便不利

慎用人群

附子有毒性，必须专业炮制、久煎、辨证使用；实热红肿痛、阴虚热盛、孕妇等特殊情况须专业医师把关。资料仅供学习。

辨证要点

骨节疼烦，掣痛不得屈伸，近之则痛剧是核心。

汗出短气、小便不利、恶风不欲去衣，提示虚寒湿痹。

可见身微肿或关节肿胀，水湿偏着关节。

恶寒重、脉沉细弱者更合附子证。

红肿热痛、口渴烦躁、脉滑数实热者慎用，应与越婢加术汤等鉴别。

相关原文

《伤寒论》175：风湿相搏，骨节疼烦，掣痛不得屈伸，近之则痛剧，汗出短气，小便不利，恶风不欲去衣，或身微肿者，甘草附子汤主之。

《金匮要略·痉湿喝病》：风湿相搏，骨节疼烦，掣痛不得屈伸，近之则痛剧，汗出短气，小便不利，恶风不欲去衣，或身微肿者，甘草附子汤主之。

医案

医案1（大塚敬节医案）：女，17岁，扁桃体炎后连续高热，四肢疼痛，继而膝、踝关节肿痛，不能站立，呼吸迫促，尿量减少，虽汗出而热不退，兼恶寒，脉浮大，舌湿无苔。连续服甘草附子汤约2个月而痊愈。十二字病理分析：阴证：恶寒、尿少、久病不解，机能沉衰。表虚：汗出而热不退，风湿在表。里寒：恶寒、舌湿，为虚寒背景。水实：膝踝肿痛、尿量...

胡希恕解析

胡希恕认为本方由桂枝甘草汤加白术、附子而来，但不能机械看成几个方证相加。临床主证常是关节剧痛、掣痛不得屈伸，兼汗出短气、小便不利、恶风不欲去衣，属阴性虚寒湿痹。



厚朴



姜



半夏



甘草



人参

厚朴生姜半夏甘草人参汤^{09/12}

里证

气证

组成

厚朴8 生姜8 半夏5 甘草2 人参1

病理

里虚

气实

病理症状

里虚

神疲乏力，脉弱舌淡

气实

腹胀满，食后加重，暖气

临床症状

腹胀满、按之不坚、不痛或微痛、时轻时重、食后加重、暖气、不欲饮食、大便不畅

慎用人群

腹满坚痛拒按、不大便、潮热谵语者为实胀，当用承气汤类方，非本方所宜。本方用于虚胀，按之不坚、时轻时重、脾虚气滞者。

辨证要点

腹胀满，虚胀为特征

腹胀按之不坚，不甚痛，时轻时重

虚人腹胀，食后或下午加重

行气药量重于补气药，消大于补

若腹满坚痛拒按、不大便，非本方所宜

相关原文

《伤寒论》第66条：发汗后，腹胀满者，厚朴生姜半夏甘草人参汤主之。

医案

胡希恕医案：胡老曾治一男性患者，感冒后自服发汗药，汗出表解。但随后出现腹胀满，自服多种消导药不效。诊见：腹胀满，按之不坚，不痛，时轻时重，食后及下午加重，伴暖气、纳差、神疲乏力。舌淡苔白，脉弱。辨为发汗后脾虚气滞，予厚朴生姜半夏甘草人参汤：厚朴24g，生姜24g，半夏15g，炙甘草6g，党参9g。服3剂，腹满大减，续服3剂而愈。十二...

胡希恕解析

胡希恕指出本方是虚胀的代表方。发汗后表解而中气伤，脾气虚则不运，气滞于腹则腹胀满。虚胀的特点是按之不硬、不怎么疼、时好时坏、时轻时重；实胀则腹满坚痛、拒按、持续不减。本方重用厚朴、生姜各半斤行气消胀，半夏和胃下气，人参、甘草补中益气。行气药力大于补气药，因为腹胀急着要消，但虚是本又不能忘。消补兼施，消大于补。临床不只限...



茯苓



人参



白术



枳实



橘皮



姜

茯苓饮

里证

水证

气证

组成

茯苓3 人参3 白术3 枳实2 橘皮3 生姜4

病理

里虚

水实

气实

病理症状

里虚

心胸间虚、不能食、纳差、胃气弱、脉弱

水实

吐水、胃内振水音、苔厚腻、头晕心悸

气实

气满、胸满、腹胀、心下痞、暖气

临床症状

胸满、胸闷、腹胀、心下痞硬、胃脘胀满、食欲不振、不能食、食后胀甚

慎用人群

若纯实胀、实热明显、无胃虚停饮象，或暖气属于苦于暖气不除者，应与旋覆代赭汤等方鉴别。

辨证要点

胸满、腹胀、心下痞，兼食欲不振

胃中停饮：吐水、痰水、胃内振水音或苔厚腻

暖气后反觉舒服，偏橘皮、枳实所主的气满

呕吐水饮重者可合小半夏汤，胀满闭塞重者可加重橘皮、枳实

相关原文

《金匱要略·痰饮咳嗽病》附方：《外台》茯苓饮，治心胸中有停痰宿水，自吐出水后，心胸间虚，气满不能食。消痰气，令能食。

医案

黄煌医案：李某，女，39岁，160cm、48kg。产后两年出现抑郁、胸中憋闷、心悸、烦躁不安、食欲差；近来上腹胀痛，食后明显，偶有反酸，大便偏溏，常头晕，入睡困难。体瘦，面黄有斑，胃内振水音，脐周动悸，舌苔厚腻，脉弱，血压偏低。处方以茯苓饮加减，服后腹胀减轻，睡眠改善。十二字病理分析：里虚：产后、体瘦、面黄、食欲差、脉弱、血压偏低...

胡希恕解析

胡希恕认为，茯苓饮所主是心胸中有痰饮、停痰宿水，吐水之后水气仍往上攻，所以心胸间虚气满、不能食。此方能够健胃进食去水，一般胃病常见胃虚、心下痞硬、停水停食而胀满纳差者，均有应用机会。若胀满、暖气明显，可加重橘皮；若恶心、呕吐水饮明显，可加半夏、生姜。

李冠杰解析

李冠杰将茯苓饮概括为虚实错杂，又有水证、气证。临床常见食欲不好、胸腹胀满、时不时暖气。辨证重点是里虚、水实、气实并见，而不是单纯补虚或单纯行气。



麦门冬



半夏



人参



甘草



大枣

麦门冬汤

里证

水证

气证

组成

麦门冬60 半夏8 人参2 甘草2 粳米4 大枣5

病理

里热

水虚

气实

病理症状

里热

火逆上气，虚热上扰，咽干口燥，咽喉不利

水虚

津液虚，咽喉缺津少液，口燥咽干，黏痰不爽

气实

咳逆上气，气逆不降，咽中痰黏缠绕，咳吐费力

临床症状

咳逆上气、咽喉不利、口燥咽干、咽中干、黏痰不爽、痰黏缠绕、咳不出咽不下、咳吐费力

慎用人群

资料整理用于学习。普通湿痰咳嗽、寒饮咳喘、里寒明显或无口燥咽干者不宜按麦门冬汤证理解；具体应用需临证辨证。

辨证要点

咳逆、咽干口燥、咽喉不利者

咳逆上气，咳嗽较深

黏痰不爽，咳吐费力

津液虚兼虚热

非普通湿痰咳嗽，须见干燥少津

相关原文

《金匱要略·肺痿肺病咳嗽上气病》：大逆上气，咽喉不利，止逆下气者，麦门冬汤主之。

胡希恕据《医宗金鉴》校注：此处“大逆上气”宜作“火逆上气”。

医案

冯世纶医案：阎某，女，44岁，2014年9月4日初诊。口中“喷火感”一月余，口干、咽干，食欲可但不消化，无腹胀，前几日齿衄，小腿肚酸胀，汗可、有时多，晨起阵汗出，不恶风，劳累后尿频急，大便黏，2~3日一行，舌淡苔薄白，脉细。辨为阳明太阴合病，方证取麦门冬汤加生石膏生姜。处方：麦冬30克，清半夏15克，党参10克，炙甘草6克，生石膏45克

...

胡希恕解析

胡希恕认为条文中的“大逆上气”宜从《医宗金鉴》作“火逆上气”理解。本方用于上焦有热、津液不足而见咳逆、咽干口燥、咽喉不利者。咽喉不利不是单纯异物感，而是缺津少液之干与黏痰缠绕并见，痰咳不出、咽不下。麦门冬大量应用，重在滋阴养液、润肺止咳；半夏下气；人参、甘草、粳米、大枣健胃安中。津液生成以胃气为本，所以本方标本同治：麦

...



葶苈子



大枣

葶苈大枣泻肺汤

12/12

半证

水证

组成

葶苈子5 大枣5

病理

半热

水实

病理症状

半热

吐黄脓痰

水实

痰黏壅盛，肺水，支饮不得息，咳逆上气，吐痰量多

临床症状

喘不得卧/呼吸困难/不得息/咳逆上气/喘鸣迫塞/咳嗽/吐痰量多/痰黏/壅盛/胸满胀/一身面目浮肿/鼻塞/流清涕/不闻香臭酸辛

慎用人群

肺病脓已成、吐脓者忌用；峻下逐水，体弱者慎用；须辨明非单纯表寒咳喘

辨证要点

痰黏壅盛，喘不得卧

支饮不得息，呼吸困难

咳逆上气，喘鸣迫塞

咳嗽后大量吐痰

肺水、痰饮壅肺（非脓已成）

相关原文

《金匮要略·肺痿肺病咳嗽上气病》：肺病，喘不得卧，葶苈大枣泻肺汤主之。

《金匮要略·痰饮咳嗽病》：支饮不得息，葶苈大枣泻肺汤主之。

《金匮要略·肺痿肺病咳嗽上气病》：肺病胸满胀，一身面目浮肿，鼻塞清涕出，不闻香臭酸辛，咳逆上气，喘鸣迫塞，葶苈大枣泻肺汤主之。

医案

（好大夫在线《葶苈大枣泻肺汤证治集要》）：尹某，男，25岁。肾病综合征进展致咳嗽、胸闷痛、心慌、气短息促，不能平卧，胸片示右侧胸腔积液。予葶苈大枣泻肺汤加味后，咳嗽气促减轻，小便增多，水肿消退，复查胸腔积液消失。

胡希恕解析

这个葶苈大枣泻肺汤跟皂荚丸是一样，都是祛痰为主。但是葶苈呢，有些治咳嗽作用，它不但能够下痰，还能治咳嗽。它说肺病喘不得卧，那这个不是在脓已成时候，脓已成了这个药不能用，那就得排脓，吃下水的药不起作用。这也就是痰黏壅盛，肺病也好，不是肺病也好。一直吐痰而不得卧有用葶苈大枣这方子。支饮不得息，葶苈大枣泻肺汤主之。这个就是...